

方幼安 张 仁 编著

针灸防治中风

K246.61F1A



上海翻译出版公司

0 元

针 灸 防 治 中 风

方幼安 张 仁 编

上海翻译出版公司

(上海武定西路 1251 弄 20 号)

本书由上海发行所发行 昆山儿童印刷厂印刷

开本 787×960 1/32 印张 2.5 字数 36,000

1987 年 7 月第 1 版 1987 年 7 月第 1 次印刷

印数 1—20,000

统一书号: 14311·45 定价: 0.80 元

前 言

中风,是一种对人类造成严重危害的病症。它不仅能直接威胁病人生命,还由于后遗不易恢复的肢体病残,往往造成患者丧失工作、生活自理能力,和社会、家庭的长期负担;而且近年来世界各国的中风发病率有日益增长之趋势。随着医学科学向生物——心理——社会模式的转化,对中风的预防、抢救及康复治疗,已经愈来愈引起世界上从事这方面工作的医学界人士的重视。

祖国医学,特别是针灸学术在中风的防治方面已经积累了相当丰富的经验,尤其是对中风后遗症的康复更有为其他医学不可比拟的长处。建国以来,在中医防治的临床和实验研究方面,在防治机理的探讨方面,都进一步取得了丰硕的成果。因此,全面地、系统地总结千百年来临床经验,包括现代的研究成果,深入揭示

其防治规律,以提高其临床效果,显然是十分紧迫而又非常重要的事情。作者运用针灸防治中风,已有数十年历史,在长期临床实践中,不断探索观察,稍有心得,特整理成文,诉诸同道,抛砖引玉,共同探讨。

我们试图在简短的篇幅中,力求为读者提供具有一定广度和深度、丰富而又实用的内容。能否做到这一点,还有待大家进一步验证。

本书读者对象主要是临床针灸医师,从事科研或教学的针灸工作者也可从中获得不少有用的信息,而对正在或即将从事中风研究的中医、中西医结合工作者,也是有参考价值的。

由于作者学识浅陋,加之编写仓促,错误之处在所难免,敬希高明不吝指正。

方幼安

一九八六年十二月

目 录

前言

第一章 概述..... 1

第二章 诊断要点..... 7

一、脑溢血..... 7

二、脑梗塞(脑血栓形成)..... 7

三、短暂性脑缺血发作..... 8

第三章 预防..... 9

第一节 古代经验..... 9

一、综述..... 9

二、方案..... 11

第二节 现代报道..... 11

一、综述..... 11

二、方案.....	13
(一) 降血脂.....	14
(二) 降血压.....	14
(三) 戒烟.....	15
第四章 治疗.....	16
第一节 急性期.....	16
一、针灸治疗.....	16
(一) 作者经验.....	16
1. 闭证.....	16
2. 脱证.....	19
3. 体会.....	21
(二) 古代经验.....	23
1. 闭证.....	23

376097-88/5/20-0.803

2. 脱证·····	25
(三) 现代报道·····	27
二、其他措施·····	28
第二节 恢复期及后遗症期·····	28
一、针灸治疗·····	28
(一) 作者经验·····	29
1. 辨证·····	29
2. 治则·····	29
3. 取穴·····	29
4. 操作·····	30
5. 方义·····	38
6. 病案举例·····	39
7. 体会·····	45

(二) 古代经验.....	55
1. 成方选辑.....	55
2. 评述.....	57
(三) 现代报道.....	59
1. 体针之一.....	59
2. 体针之二.....	61
3. 头针.....	62
4. 眼针.....	62
二、其他措施.....	64
结语.....	65
参考文献.....	67

第一章

概 述

中风,亦称“卒中”,以猝然昏仆,不省人事并伴口喎语蹇,半身不遂,或不经昏仆,而出现喎僻不遂为主症的一种疾病。其特点是起病急骤,多发生于中年以上,包括现代医学中多种急性脑血管疾病。本书着重讨论脑溢血、脑梗塞的急性期及恢复期、后遗症期的治疗,也以适当的篇幅介绍了中风的预防。

约在三千多年前,殷墟甲骨文中所谓“疾言”,就可能包括了中风引起的语言障碍。我国古代医家,在中风的认识和针灸防治实践上,创造了丰富的理论,积累了宝贵的经验。

早在二千多年前的中医经典文献《内经》中,已经从不同的角度对中风的各种症状进行了观察和探索,将其发病归纳为:外邪,尤其是风邪外侵,如《素问·风论》载:“风之伤人也……或为偏枯”,脏腑经络气血虚衰所致,如《灵

枢·刺节真邪》载：“营卫稍衰，则真气去，邪气独留，发为偏枯，”以及情志乖戾，摄生饮食不当等。在治疗上，则以针灸为主，如《灵枢·刺节真邪》认为“大风在身”，宜用针“泻其有余，补其不足”，使“阴阳平复”。

晋唐时期，由于受张仲景“风之为病”说的影响，当时医家对中风的病因，多从“虚中外风”认识，认为是外风侵袭所致。这种情况直到宋金才得以纠正。在防治上虽然出现了大、小续命汤等多种方剂，以及倡用酒剂（如独活酒、鲁王酒等）、气功导引治疗中风，但针灸仍属主要治疗方法，特别是灸法，占有十分重要的地位，如《千金要方·诸风》载中药方仅29首，而灸法却有49首。在《针灸甲乙经》、《千金翼方》及《外台秘要》等书中，也有很多这方面的记载。

宋元时期，中风病的研究在理论和防治上都有所突破。刘完素、李东垣、朱丹溪等，分别从“心火暴甚”、“本气自病”及“湿土生痰”等三方面，为中风病因病机立论，推翻了传统的“虚中外风”说。至明·张介宾在《景岳全书》中更明确指出，中风病“原非外感风邪，总由内伤气血”，并以“非风”代替中风，来明确概念。至此，内风为主的病因说，占据了统治地位。

后世医家进一步归纳为：肝风内动（风）、肾阴不足（火）或脾不健运（痰）等三种病因，指出

中风是本虚标实之病症，此三种病因，不宜孤立看待，每多相互影响，证候互见，而又各有侧重，临床上宜结合患者情志性格不同，注意生活环境各异，进行治疗。

理论上的突破，推动了防治学上的发展，如重视鉴别诊断，提倡“急屏除一切高粱厚味……更远色戒性，清虚静摄”（《医学准绳六要》）等预防之法，以及提高卒中后遗症的治疗等。在药物防治中风迅速发展的同时，针灸防治也获得了较大的进展。值得一提的是宋·王执中所撰《针灸资生经》专辟《中风》章节，大量收录了宋代以前诸医家及其本人的防治经验，对后世产生较大影响。至明代，各种针灸典籍中，都将中风的救治，列在显著地位，不仅详细介绍初中风（闭证、脱证）的急救方法，中风瘫痪的刺灸，而且还较深入地探讨了提高针灸治疗效果的途径及针灸治疗中风的机理。

现代有关针灸救治中风的报道，最早出现于五十年代初期，其中，最为急重的脑溢血，五、六十年代也有多篇报道，有些文献还累计了较多的病例^[1,2]。随着经络穴位刺激方法的不断增加，使疗效相应有所提高。但目前脑溢血的救治，还要依靠中西医疗法的密切配合，其中以针刺为主治疗的有效率在60%左右^[3]。动脉硬化性脑梗塞的疗效要好得多，七十年代初

兴起的头针疗法，对脑梗塞急性期有明显的效果。近年来，天津中医学院运用被称之为“醒脑开窍法”的针刺治疗，可用于任何一期，其有效率达到99.4%〔4〕。中风恢复期及后遗症期的治疗，这方面的文献最多。在治疗方法上，既可兼用针药，亦可单用针灸，除体针之外，头针、电针、耳针、穴位注射、激光穴位照射以及超声波刺激等都有一定效果。为了提高疗效，多采取几种穴位刺激方法综合应用，有的还把针刺与拔罐、中药熏洗、紫外线照射及体育疗法结合起来〔5〕。在用穴上，各地不一，且较繁杂，据不完全统计，约有百余个，其中以手足阳明经、少阳经及足太阳经经穴为最多用。在手法上，一般主张平补平泻法。有的采用巨刺、缪刺，有的先针健侧穴用泻法，后针患侧穴用补法，也有人只针患侧穴，采用强刺激或中强刺激。这一时期的疗效，以就医早、针感强者较好，多数报告有效率为90%左右。而综合几种刺激方法（如头针加体针），较之单一针刺效果似更好。另外，边运针边活动患肢（自动或被动）效果亦佳。

为了验证针灸疗效的可靠性，有人曾对急性缺血性脑血管病患者，分别采用针刺和烟酸治疗，通过对比观察发现，两组间疗效无显著差异〔6〕。最近，我们曾对53例中风偏瘫患者，应用CT明确诊断其病变性质、病灶部位和范围

在住院条件下进行严密的临床观察，也证实针灸对中风有肯定的治疗效果，并优于一般药物治疗[7]。需要一提的是中风自愈问题，鉴于部分中风患者有自发性代偿倾向，在一定程度上影响了疗效评价，对此，我们曾将针刺的效果与只用支持疗法的资料相对照，发现针刺的疗效，远较支持疗法为好，有明显的统计学意义[7]。我们还对同用一般药物的针刺组与非针刺组作了比较观察，也证明针刺组的有效率较高($P < 0.05$)。

探索针灸治疗中风的机理，近年来已作了大量工作。通过对患者的脑电图、脑血流图、血液流变学指标及血清脂蛋白等治疗前后的测定，表明，患者血液的浓稠性(血球积压)、粘滞性(全血比粘度)、聚集性(血沉方程K值)有显著的改善，脑血管扩张，周围阻力减小，脑血流量增加，并使异常脑电图逐渐恢复正常。提示针灸可增加中风患者脑部血液循环，提高脑组织的氧分压，加强病灶周围的脑细胞营养，改善抑制的皮层状态，增强代谢机能，减轻病变部位的缺血缺氧状况，从而促进脑组织的修复，有利于瘫痪肢体和语言障碍的恢复[6,8]。

另外，有采用诱发肌电的方法来研究针刺对脑血管患者的作用，也证明针刺可以提高偏瘫患者的运动功能，促使低下的运动功能恢

复[9]，进一步分别观察体针、电针和头针对患者肌电幅度的影响，结果发现，体针和电针能使肌电幅度升高，而头针则未见明显变化，表明不同的刺激存在着作用上的区别[10]。

从以上文献综述来看，针刺治疗中风的疗效是肯定的，加上针刺疗法本身所具有的简便、安全、价廉等优点，它作为治疗中风病的一种优先方法已愈来愈引起人们的重视，预期这种方法将日益广泛地被人们所采用，它将为人类保健事业作出巨大的贡献。

第二章

诊断要点

一、脑溢血

(一) 多见于50岁以上,且有高血压病史。

(二) 常在体力或脑力劳动紧张时或在其它活动中发病,表现为突然发生昏迷、瘫痪,面色苍白或潮红、大汗淋漓、二便失禁等,血压升高,偶见抽搐;常伴剧烈头痛和呕吐。

(三) 病情进展迅速,多表现为完全型中风。

(四) 实验室检查,白细胞计数增高,小便蛋白定性常为阳性,脑脊液压力增高,含出血者占80%以上。

(五) 注意和其它急性脑血管疾病如蛛网膜下腔出血、脑血栓形成、脑栓塞等鉴别。

二、脑梗塞(脑血栓形成)

动脉硬化性脑梗塞约占急性脑血管病的50~60%。

(一) 本病在60岁以后发病率增高,男性稍多于女性。可能有前驱的短暂脑缺血发作史。一般有脑动脉硬化史。

(二) 安静休息或睡眠时发病较多,常在晨间睡醒后出现症状。

(三) 通常不出现意识障碍,面色较苍白,脉搏较快。偏瘫、失语等局灶性神经功能缺失比较明显。症状通常在几小时至1~2天内逐渐加重,呈进展性中风类型。

(四) 实验室检查:一般脑脊液清晰,压力不高,偶有少数红细胞或白细胞和蛋白质的轻度增加。

(五) 注意与脑溢血、颅内占位性病变、颅脑损伤及脑栓塞等鉴别。

三、短暂性脑缺血发作

(一) 发病年龄都在50岁以上,有动脉粥样硬化史。

(二) 起病突然,历时短暂,常为某种神经功能缺失,发作数分钟至数小时,在24小时内恢复大都无意识障碍。

(三) 常可反复发作,临床症状可刻板出现。可每日数次亦可数月乃至数年才发作一次。间歇期无任何症状。

(四) 应注意同局限性癫痫、心脏病诱发的短暂性脑缺血发作及内耳性眩晕等鉴别。

第三章

预防

中风病急势重,常带来严重后果,给家庭造成不幸,给社会增加负担。正如晚清医家吴亦鼎所言,“若非预防平时,而欲图功于末路则幸而生全者,良亦苦矣”(《神灸经纶》)。现代,随着物质生活的日益丰富和精神生活的节奏加快,本病发病更有不断增加的趋势,所以,预防中风的发生,应为本病防治的关键。下面重点介绍古今针灸预防中风的经验。

第一节 古代经验

一、综述

我国古代最早提到采用针灸之法预防中风的是唐·孙思邈,他在《备急千金要方》中明确指出:“惟风宜防耳,针耳前动脉及风府神良,”除针刺外,他还提倡服药和艾灸相结合:“夫诸急卒病多是风,初得轻微,人所不悟,宜速与续命

汤，依输穴灸之。”

从宋代至明清，在多种针灸典籍中都记载了预防中风的具体方法，并积累了相当丰富的经验。

首先，鉴于中风有中脏、中腑之别，预防之法亦应据此而有所不同，如《针灸资生经》载：“觉心中愤乱，神思不怡或手足麻，此将中脏之候”，可依此自上及下，灸百会、曲鬓等十三穴各五壮。而“手足不随，其状觉手足或麻或痛，良久乃已，此将中腑之候，病左灸右，病右灸左。”

其次，《针灸资生经》还总结了行之有效的艾灸结合煎洗的预防方法：“凡人未中风，一两月前，或三、五月前，非时足胫上忽酸重顽麻，良久方解，此将中风之候。急灸三里、绝骨四处三壮，后用葱、薄荷、桃柳叶煎汤淋洗……常令两脚有疮为妙。”此法自宋·王执中记述后，由于效果好，颇为后世推崇，除明·朱橚《普济方》收载外，明代著名针灸家杨继洲在其《针灸大成·治症总要》中，也将此法冠于篇首；现代研究也证实确有明显预防中风的作用，这将在下面提到。

此外，《普济方》还载，对于易于中风的“有风之人”，不应该等到有上述中风之候再施灸，平时亦须重视预防，“凡遇春秋，常灸以泄风气，素有风人，可保无虞。”

最后，除了用上法外，古人还强调注意摄生，也是预防中风的有效措施之一，如《针灸资生经》载：“饮食不节，酒色过度”，亦可“忽中此风。”

二、 方案

古代针灸预防中风的经验，可归纳如下：

(一) 取穴

主穴：绝骨、足三里。（《针灸资生经》）

配穴：百会、风池、大椎、肩井、曲池、间使。

（《类经图翼》）

(二) 治法

一般单用主穴，如效不显加用配穴，直接灸，炷如半枣核大，每灸3~5壮。灸后，宜用葱、薄荷、桃叶、柳叶煎汤淋洗。

第二节 现代报道

一、 综述

现代以针灸预防中风，虽还不够普遍，但已日益引起重视。通过我们自己的临床实践，基本证实通过针灸治疗可以改善诱发或导致中风的一些主要病症，来预防中风的发生是行之有效的。

现代医学认为引起中风即脑血管病发病的最主要原因是动脉粥样硬化，其次为高血压病伴发的脑动脉改变^[11]。另外，饮食不节，心理

及环境因素亦是其中的因素。已经查明，动脉粥样硬化与血脂增高，特别是血中胆固醇、甘油三酯增高的关系最为密切。吸烟，由于烟的尼古丁可使血管挛缩，血压升高，加速动脉粥样硬化的发生，亦可增加中风的发病率。我们曾统计过500位吸烟者，其中患心、脑血管病者占297人，可见吸烟和脑血管病关系颇为密切。

针刺降脂，国内从五十年代开始即有报道，但多散见于治疗高血压及冠心病等文献中，并有动物实验的资料。国外从1976年开始有针刺及电针治疗高血脂症的报告。为了寻求取穴少、操作简便而又疗效确切的方法，我们于1981年10月~1982年5月，在实验条件下，对72例高血脂症病人，采取针刺单侧内关穴进行治疗，针刺前后作比较，结果胆固醇、甘油三酯、 β -脂蛋白三者含量下降均有极显著统计学意义（ $P < 0.001$ ）。其中 β -脂蛋白在停针后经一年随访仍明显低于针刺前水平，说明有显著的疗效^[12]。最近，有人重复了我们的工作，以氦-氖激光照射内关穴，也证明确有明显的降低血中高胆固醇含量的作用^[13]。

针灸降压有明显的效果，无论针刺、艾灸以及耳针、穴位注射、激光照射、磁疗等都有较好的作用。最值得一提的是有人报道^[14, 15]，通过对古人经验进行科学验证，发现《针灸资生经》

所载预防中风的绝骨、足三里二穴，经痕疤灸后，除血压显著下降外，病人的血液粘度、脑血流图也有明显改善，大小血管出现一定程度的扩张。经为时十七年之久的观察，54例用此法预防的高血压患者，只有5例发生中风，而对照组12例中，却有4例得了中风，表明灸治上穴确有预防中风的作用。近年来，我们在临床上采用耳穴压丸的方法降压，也有一定效果，由于方法简便，病员可自行操作，痛苦小，疗效维持时间长，比较受到病员的欢迎。

吸烟对人体的危害，已为人所共知，对心、脑血管的影响也十分严重，我们曾对500例耳针戒烟者做过调查，发现其中有297例患有心、脑血管病，其中一部分人如不戒除继续吸烟，势必造成心、脑血管病的进一步恶化。针刺戒烟，在八十年代初我国开始重视，我们从1980年起，通过2000余例的实践，已经证明针刺（耳针）确有明显的戒烟效果，多数戒烟者反映，针后烟味变淡、变苦、变辣，吸不进和不想吸。并通过临床研究提示，耳针戒烟不能用心理因素来解释^[16]，经耳针戒烟后，心、脑血管病的症状均能得到改善。进一步的工作还发现，针刺耳穴可调整血浆亮-脑啡呋等的含量^[17]，表明有一定的物质基础。

二、 方案

(一) 降血脂

1. 取穴:内关。

2. 治法:每次只取一侧穴,左右交替,隔日一次。快速进针后,行提插加小捻转手法,提插幅度2~3毫米,捻转频率120次/分左右,得气后,行针2分钟,留针20分钟,每隔5分钟以同样手法行针1次,亦2分钟。10次为一疗程,间隔3~5天后,再作第二疗程。一般治疗2~3疗程。如有条件,亦可以氦氛激光照射本穴,两侧交替。波长6328 Å,输出功率2~3毫瓦,光斑直径为1~1.5毫米,每日1次,每次15分钟,10~12次为1疗程。

(二) 降血压

1. 取穴:(1)悬钟、足三里。

(2)曲池、丰隆^[18]。

(3)(耳穴)额、肝、心、降压沟、交感。

2. 治法:每次任选一组,如效果不佳,亦可互相配合。(1)组,可以麦粒灸,亦可用艾条熏灸。直接灸按常规化脓灸法,每次麦粒灸两侧穴,3~7壮,以灸穴上有小水泡为度,间日复诊,如未发灸疮,原穴再灸,一般待灸疮愈合后复灸(约月余一次)。艾条熏灸,以市售艾条点燃后在穴区以雀啄法熏灸,两侧穴位均灸,每次灸10~15分钟,直至局部皮肤潮红起泡为度,每

日或隔日1次,10次为1疗程,间隔3~5天继续下1疗程。(2)组,以泻法为主,得气后留针15~20分钟,间隙运针。待血压平稳后,则改为补法,每日1次,8周为1疗程,血压正常后,每周针刺2~3次。(3)组采用耳穴贴敷。方法是将王不留行籽置于 0.5×0.5 毫米之胶布块上,每块一粒,选准耳穴后,每穴贴一块,每次贴一侧耳,1周2~3次,左右轮换,令病人自行按压,要有胀痛感,每日3~4次,每次每穴按压5分钟左右。20次为1疗程,间隔1周后,继续贴敷。

(三) 戒烟

1. 取穴:(耳穴)口、肺、神门。

2. 治法:按耳针常规操作,患者要有明显痛感,以耳郭潮红发热为佳,留针15分钟,取双侧穴,每周2~3次,6次为1疗程。亦可针后于一侧耳穴上贴敷王不留行子。方法同上。

第四章

治 疗

第一节 急性期

中风急性期是指突然发生的急性血管源性脑功能障碍,常可在24小时内死亡,所以这一时期的救治殊为重要。现将作者多年经验及古今有关这方面的记载和研究,分述如下。

一. 针灸治疗

(一) 作者经验

1. 闭证

(1) 辨证:突然昏仆,不省人事,牙关紧闭,口噤不开,双手紧握,二便闭阻,肢体强痉。偏于阳证者,可兼见面赤身热,鼾声呼吸,躁扰不宁,舌苔黄腻,脉象弦滑数实。偏于阴证者,可兼见面白唇暗,静卧不烦,四肢不温,痰涎壅盛,舌苔白腻,脉象沉滑而缓。

(2) 治则:开窍熄风。阳闭者佐以清肝,阴者益以祛痰。

(3) 取穴：水沟，十二井穴、内关、合谷、太冲。阳闭加风池、劳宫；阴闭加丰隆、公孙。

(4) 操作：

水沟：针尖微向上进针，可刺至龈交穴，留针。留针时作间隙运针，大幅度捻转。起针时，用开合补泻法的泻法，不揉按穴孔，可刺出血。宜用28号毫针。

十二井穴：先取中冲、少冲，进针1~2分深，大幅度捻转，出针时不揉按穴孔，挤出血数滴。宜用28号毫针。如反应不强、疗效不显，再续刺其它井穴，方法同前。

内关：取针芒法，针尖向心方向进针，可进针1~1.5寸。破皮进针后，医者左手食指放在患者手指的一端，即心脏之远端，稍用力按压，阻隔针感下行，右手持针缓缓进针，小幅度捻转导气，起针时不按穴孔。用30号毫针。

合谷：取与手背呈平行方向进针，可进针1.5寸左右。用徐疾补泻法之一进三退泻法，中等幅度捻转，起针时不按穴孔。用30号毫针。

太冲：取针芒法，针尖向心方向进针，可进针1.5寸左右，用徐疾补泻法之一进三退泻法，大幅度捻转，起针时不按穴孔。用30号毫针。

风池：患者在昏迷时，多取仰卧位，因此在进针时，应将患者头部轻轻地略转向一侧，以便于进针和操作，宜先针一侧，起针后再针另一

侧。针尖对同侧瞳孔直视方向进针，根据患者肥瘦进针 0.8~1.2 寸。进针时直达一定深度，留针，留针时作间隙运针，用徐疾补泻法之一进三退泻法，小幅度捻转，起针时不按穴孔。用 28~30 号毫针。

劳宫：取针芒法，针尖向心方向逆针，可进针 1~1.5 寸，留针，留针时间隙运针，用徐疾补泻法之一进三退泻法，大幅度捻转，起针时不按孔穴。用 28 号毫针。

公孙、丰隆：均用平补平泻法。

(5) 方义：水沟属手足阳明、督脉之会，能醒脑宁神；十二井穴能开窍熄热；内关为手厥阴之络穴，别走少阳，通于阴维脉，八脉交会穴之一，能宁心安神；合谷为手阳明之原穴，能疏风通络；太冲为足厥阴之输穴、肝之原穴，能平肝阳熄内风，理血通络；合谷与太冲同用，称为开四关，能苏厥。风池为手足少阳、阳维之会，能平肝熄风解热；劳宫为手厥阴之荣穴，能清心泄热；丰隆为足阳明之络穴，别走太阴，能化痰湿、宁神志；公孙为足太阴之络穴，别走阳明，通于冲脉，八脉交会穴之一，能健脾利湿化痰。丰隆与公孙合用能相辅相成，相得益彰，更有利于清化痰湿。

(6) 病案举例：何××，女，56 岁，以往不知有高血压史。1974 年 2 月 18 日晚，突然发病，

感到头部剧痛，迅即昏迷，不省人事，面赤，鼾声呼吸，脉象弦滑而实，血压 240/120 毫米汞柱，经西医急诊处理，12 小时后仍昏迷不醒，乃加用针灸。先刺人中，针尖向上，用大幅度捻转，仅有微弱反应，留针。同时取双侧中冲、少冲，大幅度捻转约 1 分钟后，起针，挤出少量血液。再取双侧合谷、太冲，用一进三退之泻法，大幅度捻转持续 10 分钟，患者出现一侧上下肢颤动。同时，对水沟所留之针，再用大幅度捻转，患者出现头部左右摇动，伴有含糊不清之发音。共留针 15 分钟，患者尚未见清醒。1 小时后，再刺风池，双侧，分两次针刺，用一进三退小幅度捻转，各持续 5 分钟，患者仍无明显反应，起针后，再刺双劳宫穴，因患者紧握拳，乃掰开双手，用针芒法，针尖向心，进针 1 寸半，用大幅度捻转提插，持续 5 分钟，患者出现挣扎反抗，摇动身躯，伴呼喊声。起针后，刺左侧内关穴，用针芒法，针尖向心，阻气下行，用小幅度间隙缓慢捻转，持续 10 分钟，患者出现眼睑翻动，家属在旁呼喊患者名字和称谓，患者出现长吁气和叹息，几分钟后逐渐苏醒。

2. 脱证

(1) 辨证：突然昏仆，不省人事，目合口张，息微，手撒肢冷，汗多，二便失禁，肢体瘫软，舌痿，脉象微弱。

(2) 治则：扶正回阳固脱。

(3) 取穴：百会、人中、风池、内关、合谷、太冲、神阙、关元、足三里。

(4) 操作：

百会：针尖向后，进针1~1.5寸，留针。留针时作间隙运针，小幅度捻转。起针时用开合补泻法之补法，揉按针孔。宜用30~32号毫针。

神阙：隔盐灸，艾炷如半个枣核大，可灸20~100壮。

关元：隔姜灸，艾炷如半个枣核大，可灸20~100壮。

足三里：进针1.5寸左右，留针。留针时作间隙运针，中等度捻转提插，平补平泻。宜用30~32号毫针。直接灸，艾炷如麦粒大，灸5~15壮。

余穴操作同闭证，用补法。

(5) 方义：百会为手足三阳、督脉之会，能开窍宁神，平肝熄风，升阳固脱；神阙属任脉，能温阳固脱，健运脾胃；关元为足三阴、任脉之会，小肠募穴，能固本回阳；足三里为足阳明经合穴，能扶正补虚；余穴已详前述。

(6) 病案举例：张××，女，52岁，有冠心病、糖尿、高血压病史，肥胖体型。1983年12月21日下午出现嗜睡，浅昏迷，呼之答应，反应迟钝，入晚逐渐昏迷加深，呼之不应，周身汗出，汗液粘，四肢不温瘫软，脉象细弱，血压120/100毫米

汞柱，经急诊处理，翌晨仍昏迷不醒，乃加用针灸。先针百会，按上述操作方法，留针。患者无反应。加刺人中，针尖向上，用大幅度捻转，留针。患者反应不强。再加双侧合谷、太冲，大幅度捻转持续10分钟后，患者出现头部转动，四肢抽动，伴含糊发音。留针。留针时，同时捻转人中所留之针，当再次捻转人中时，反应虽较前明显，但仍未清醒。此时，除上述各穴留针外，加灸神阙（用上述操作法），灸至15壮，四肢渐温，自汗渐敛，再捻转人中、合谷、太冲等穴时，患者出现反应明显，摇动头部身躯，四肢挣扎，口中含糊呼叫，眼睑翻动。共灸20壮，灸毕起针，1小时后，患者逐渐苏醒。

3. 体会

闭证与脱证可以同时互见，也可以相互转化。如闭证治不及时，或贻误病机，或正不胜邪，可以转为脱证；脱证经过及时治疗或正气渐复，也可转为闭证。所以在闭脱转化过程中，有时会出现闭脱互见的证候。闭证而出现脱证的证候是病情转重的趋势；脱证而出现闭证的证候是正气渐复的象征。

针灸用于急症，包括闭证与脱证的处理，在历代文献和现代研究都有记载。近代曾有人认为由于针刺具有活血作用，不主张对脑溢血患者在昏迷期或早期使用，但仍有人报道^[3]采用

中西医结合针灸并用治疗脑溢血 48 例,有效率在 60% 以上。但提出对于脑溢血病人,在针治过程中要随时测量血压,如血压有明显升高者,要操作谨慎,必要时暂停针刺。但并未发现有人报道由于针刺直接造成脑溢血患者死亡;作者多年来曾用针灸结合中西医药治疗脑溢血患者昏迷期多例,均有一定疗效,闭证的疗效优于脱证。

在操作方面:对十二井穴的选用,属于阳证之闭证,伴有发热者,可先刺阳经井穴,并挤出血数滴。因阳经均与督脉交会,刺阳经井穴较之刺阴经井穴更能泄热以开窍,此“热则泻之”与“菀陈则除之”之意,可普遍用于阳性闭证。对邪入心包、痰迷心窍者,如急性脑溢血闭证,可先刺中冲与少冲,因此二穴属心包与心经,对开窍醒脑之作用,常优于其它井穴。对不属于深度昏迷之患者,刺此穴并出血后,常有效,如不理想,可再刺其它井穴。

刺劳宫穴之操作法,因手掌骨间肌不丰厚,不宜直刺,直刺过浅,则针感不强,不易达到促使患者苏醒之目的,故宜取针芒法,便于行使手法,易于促醒患者。

内关穴之操作法,对苏醒的患者可感到针感缓慢向上传导,最佳感传可以达到胸部,即使不能到达胸部,凡有针感向上行至臂、肘者,亦能较快或逐步缓解症状。

艾灸神阙、关元穴治脱证，确有扶正回阳之效，作者曾用针刺结合艾灸此二穴，治疗闭、脱互见之胸外科手术后昏迷长达21天之患者，在原用药物基础上加针灸后，三天后即复苏，因此对急性脑溢血脱证昏迷也同样可用，并有一定疗效。

（二） 古代经验

1. 闭证

（1） 成方选辑

《千金翼方》

卒中风口噤不得开：颊车二穴，灸五壮。

卒中风：鼻交颞中一穴，针入六分，得气即泻，留三呼，泻五吸，不补。亦宜灸，然不及针。

《普济本事方·卷一》

始则口眼歪斜，次则涎潮闭塞，听会、颊车、地仓、百会、肩髃、曲池、风市、足三里、绝骨、大椎、风池。

《针经摘英集》

治中风口噤牙关不开：水沟、颊车，针入四分，得气即泻。

气塞涎上，不语昏危：百会、风池，针入七分；大椎，针入五分；肩井，只可针入五分；曲池、间使，针入三分；（足）三里等七穴。以取尽风气，神清为度。

《神应经》。

口噤不开；颊车、承浆、合谷。

不识人；水沟、临泣、合谷。

《医学纲目》：

中风不语，不省人事；顶门、百会、中冲、大敦、十指尖出血。

《乾坤生意》：

凡初中风跌倒，卒暴昏沉，痰涎壅滞，不省人事，牙关紧闭，药水不下，急以三棱针，刺手十指十二井穴。

《针灸大成》：

中风不省人事；人中、中冲、合谷。前穴未效，复刺后穴；哑门、大敦。

中风口噤不开；颊车、人中、百会、承浆、合谷（俱宜泻）。前穴未效，复刺后穴，廉泉。

（2）评述

中风闭证的针灸治疗，历代医家颇为重视，并积累了丰富的经验。随着对中风病因认识的深入，到明代无论在取穴、操作上都日趋成熟，其救治重点，集中于不省人事，卒暴昏沉的昏迷证候。

取穴特点，较为常用的穴位是，昏迷：十二井穴（或十宣）、水沟、百会、肩井、中冲、大椎、大敦、足三里。口噤不开：颊车、承浆、合谷。大致和现代相似。取穴时，还提到须保持一定姿势，如颊车，“令人侧卧，张口取之”（《普济方·针灸

门》)。

操作特点,以针刺为主,其中十二井穴(或十宣),宜用三棱针急刺出血。其余则强调行针用泻法,或只泻不补,或先补后泻,或得气即泻,亦有用灸法治疗。但早在唐代,孙思邈就指出:“亦宜灸,然不及针”(《备急千金要方·卷八》)。闭证针灸,一般要求留针和加强手法,以神清为度。

《普济方·针灸门》对针灸效果不佳的情况作了细致的分析,认为可能与下列因素有关:“一则不中穴,二则虽中穴,刺之不及其分;三则虽及其分,气不至出针;四则气虽至,不明补泻。”特别是,由于针刺不当造成“随针而卒,”其原因“一则不知刺禁,假令刺中心即死之类是也,二则不明脉候。”所以要求在治疗中风时,必须“详审脉候,观察病证,然后知其刺禁,辨其经络穴道远近,气候息数,深浅分寸,然后知其病刺之”,则可“获时而愈”,强调“不可一途而取,不可一理而推之”。这些,对今天临床也有一定借鉴意义。

2. 脱证

(1) 成方选辑

《千金翼方》:

凡大风,灸百会七百壮。

《神应经》

疗中风戴上(按:即戴眼之意)及不能语者,灸第三椎并五椎上,各七壮,用灸炷如半枣核大。

《普济方·针灸门》

治风入脏,吻边横纹,赤白肉际,逐左右灸,随年壮报之,至三日不差,更报之。

《针灸聚英》:

中风:神阙、风池、百会、曲池、翳风、风市、环跳、肩髃,皆可灸之。

《类经图翼》

凡卒中风者,神阙最佳。

戴眼:神庭、脊骨三椎五椎,各灸五、七壮,齐下火,立效。

(2) 评述

中风脱证,较之闭证危重,死亡率高,直至清代,针灸医家吴亦鼎仍认为“中风……甚则口开,心绝;手撒,脾绝;目合,肝绝;遗尿,肾绝;声如鼾睡,肺绝。五症全者,死不治”(《神灸经纶》)。故特别强调急救,如《千金翼方》载:“卒死之人及中风不得语者,皆急灸之,夫卒死者是风入五脏。”

脱证,昏迷不醒者取神阙、百会为主穴。戴眼(戴眼是病情危重的表现之一,首见于《素问·诊要经终论》,张景岳释为“戴者,戴于上也,谓目睛仰视而不能转也。”)者加取神庭、脊骨

(胸椎)三椎、五椎。

治法上,多用灸法。灸之壮数,一般要求多灸,如《千金翼方》载灸百会七百壮,但也有提出灸五七壮的,当视病情不同而言。张景岳还认为灸壮多少,与施灸部位有关:“灸头面者,艾炷宜小,亦不宜多,灸手足者稍倍之,灸腹背者又倍之”(《类经图翼》)。灸的操作,除神阙外,一般用直接灸,艾炷如枣核大。神阙穴采取隔盐灸,《景岳全书·杂证谟》还介绍了一种隔盐隔姜灸:“灸非风卒厥、危急等症,神阙用净盐炒干,纳于脐中令满,上加厚姜一片盖定,灸百壮至五百壮,愈多愈妙,姜焦易之。”

古人还探讨了灸治本病的机理,宋·王执中《针灸资生经》中认为,应用灸法,可“驱逐风气自疮口出”。这个认识本于唐·孙思邈《千金翼方》:“凡一切中风,服药盖剧者,但是风穴,皆灸之。”明代张景岳的看法较为深入,他认为,卒中风灸神阙,“盖不惟逐散风邪,宣通血脉,其于回阳益气之功,真有莫能尽述者”。

(三) 现代报道

1. 取穴

主穴:水沟、承浆、风池、十二井、天突。

配穴:太冲、大椎、劳宫、百会、涌泉、气海。

2. 操作 先重按天突,继自华盖到膻中从上至下按3~6次,以防患者窒息。以主穴为

主,效果不佳时再选用配穴。十二井刺出血,余均用轻而短的刺激,以捻转结合提插手法连续运针2分钟,气海穴可在针后加灸,病情重者采取直接灸,艾炷如黄豆大,一般以艾条薰灸,直至皮肤潮红起泡。

3. 疗效评价 以针灸为主,配合中西医药物治疗,共治74例,痊愈及有效45例,死亡29例,总有效率为60.8%[1,2]。

二、其它措施

(一) 保持安静的诊疗环境,坚持守候护理,密切注意病情变化。

(二) 积极配合中西医药物治疗,包括降血压、控制脑水肿,高热感染者给予抗菌素,呼吸困难者吸入氧气,吞咽困难者宜用鼻饲。

(三) 如针灸效果不佳,改用中西医药疗法。

第二节 恢复期及后遗症期

中风急性期得到控制,病情稳定后即进入恢复期,因恢复不全而遗留各种病残,则称为后遗症。在上述时期,针灸治疗常优于其它疗法,恢复期和后遗症期的刺灸主要方法相似,在具体取穴、操作上则根据所出现的各种症状不同而有所区别,故本节作一并叙述。

一、针灸治疗

(一) 作者经验

1. 辨证 头痛、眩晕、口喎、面部麻木、一侧肢体麻木、沉重或瘫痪，病在右肢者多伴有失语或语言蹇涩，脉象弦滑而实等证。

2. 治则 活血化瘀，平肝熄风，舒通经络。

3. 取穴

(1) 对症取穴

① 头痛、眩晕：百会、四神聪、风池、太阳、合谷、太冲。

② 失语、舌麻、味觉减退或消失：哑门、廉泉。

③ 口喎：下关、地仓、颊车、迎香、承浆。

④ 上肢麻木、沉重、瘫痪：甲组，肩髃、手三里。乙组，曲池、四渎。

⑤ 上肢抬举疼痛：天柱、天鼎。

⑥ 肘关节僵硬(肌张力高)：曲泽。

⑦ 手指僵硬(肌张力高)：大陵、三间、后溪。

⑧ 下肢麻木、沉重、瘫痪：甲组，环跳、委中。乙组，足三里、阳陵泉。丙组，髀关、足三里。

⑨ 膝关节僵硬：犊鼻、委中。

⑩ 足趾僵硬：太白。

(2) 整体取穴

① 形体丰腴，苔腻痰多者：脾俞、公孙、丰隆。

② 形体偏瘦，舌红少苔者：肾俞、复溜、太溪。

③ 舌胖边有齿痕者：气海、足三里。

④ 反应迟钝，情绪易于波动，甚至哭笑失控者：脑户。

⑤ 血脂或血粘度高，脉象弦滑实数者：风池、风府、内关。

4. 操作

百会 针尖向后，进针1~1.5寸，留针15~20分钟。留针时间可间隙运针，一般用平补平泻，高血压患者可用泻法。

四神聪 四针向心(百会穴)，进针1寸，留



图1 俯视

针15~20分钟。可间隙运针，一般用平补平泻，高血压患者可用泻法。

风池 用于因高血压目糊伴头额胀痛，取



图2 侧视

同侧瞳孔直视方向进针，针深1寸左右，小幅度捻转，得气后导气上行，针感可循顶部、额颞部并可达阳白穴和眼区，留针15~20分钟。风池穴进针定向方法：当左手食指指在瞳孔直视方向位置与右手所持之毫针成一直线时，即为本书所介绍之进针方向(见图1、2)。

太阳 一般书籍定位在丝竹空与目外眦联线之中点，或三点成等边三角形。作者在临床实践中，常按上述定位以水平移至鬓发际进针，浅针横刺，向鬓发内以水平方向进针1~1.5寸，小幅度捻转。对安神宁志，缓解头痛有较好疗效，

留针30分钟。

廉泉 进针1.5寸左右,针感抵舌根,留针15~20分钟。

下关、地仓、颊车 均取透刺法,进针1.5寸左右,浅针横刺,留针15~20分钟。

肩髃、手三里、曲池、四渎 进针1~1.5寸(四渎穴以进针1寸左右为宜,过深效差),分甲、乙两组,每次取一组,接通电麻仪,频率120次/分,通电15~20分钟。要求手背、手指出现节律性背屈。



图3 患者肩关节痛,不能抬高

天鼎、天柱 以往文献记载和现代报道均少见能治中风偏瘫，但作者个人经验，此二穴对中风患者肩关节运动时疼痛有良好的治疗效



图4 在天鼎穴进行针刺，用“捻转补泻”的泻法运针果，但应注意以下取穴与操作：不论患者主动抬肩或被动运动时肩关节疼痛者，如痛在肩后，可在天柱穴摸压，如痛在肩前，可在天鼎穴摸压，多可摸到块状或条索状结节，并伴有明显压痛，在压痛点上进针，捻转得气，加强针感。凡能主动运动者嘱患者同时抬举活动；凡不能主动抬肩者，可由他人帮助抬举活动。不论原来能否活动，均在留针时边捻转运针边运动，可留针15~20分钟，中间间隙运针，加强针感，在留针时间内根据患者体力耐受程度，间隙运动肩关节。天柱、天鼎穴结节压痛，会随症状之明显而出

现,也会随症状之缓解而消失。根据经络学说,天柱穴属足太阳经,肩后面为足太阳经筋所分布;天鼎穴属足阳明经,肩前面为足阳明经筋所



图5 在针刺过程中,捻转运针的同时,
嘱患者不断抬举患肢

分布,故当发生病痛后,经络之气阻滞,不通则痛,故在循行之经络上可出现结节压痛,这种结节压痛在健康一侧一般不会出现,故结节压痛与病痛呈平行关系。作者用上述方法治中风肩痛,颇为得心应手(见图3、4、5、6)。

曲泽 位置在肱二头肌腱内侧,进针后斜刺,刺向肱二头肌肌腱,进针1寸左右,大幅度捻转1~2分钟,不留针,针感强烈。

大陵 针尖向劳宫穴,进针1~1.5寸,先用捻转泻法,再留针15~20分钟,针感强烈。

三间、后溪 均进针1.5寸，先用捻转泻法，针感强烈，再留针15~20分钟，接通电麻仪，用持续波，要求患者有轻微震颤感(见图7、8、9)。



图6 用上述方法针刺一段时间后，肩痛
逐步缓解，可以举高

环跳、委中；足三里、阳陵；髀关、足三里
进针1~2寸，分甲、乙、丙三组，每次取一组，接
通电针仪，频率120次/分，通电15~20分钟。要
求足背、足趾出现节律性背屈。

太白 进针1~1.5寸，先用捻转泻法，针感
强烈，再留针15~20分钟，留针时，间隙运针

2~3次。

脾俞、公孙、丰隆(均双侧),用平补平泻,留



7 患者上肢肌张力高,手指僵硬,紧握拳,不能伸开

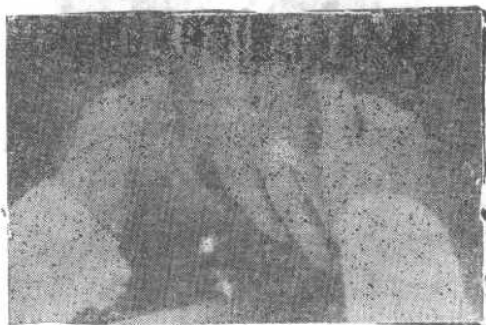


图8 在三间穴与后溪穴同时针刺,两手同时操作,用“捻转补泻”的泻法运针,能在1、2分钟内手指完全自动伸开

针15~20分钟。

肾俞、复溜、太溪、气海、足三里(均双侧)，用补法，留针15~20分钟。

脑户 针尖向后，沿皮浅刺，进针1~1.5寸，小幅度捻转0.5~1分钟，用平补平泻法，留针15~20分钟。



图9 在留针时间内手指能持续伸开，并能相对稳定一段时间

风府 平刺，进针0.5~1寸，小幅度捻转，局部酸胀，用平补平泻法，留针15~20分钟。

内关 针尖向上，斜刺进针1~1.5寸，提插得气后，施以提插加捻转之法，提插幅度2~3毫米，捻转频率120次/分，留针15分钟。

以上各穴每日或隔日针刺1次，10次为1疗程。

附：激光照射操作，主要用于治疗偏瘫

(1) 取穴与针刺治疗上下肢瘫痪基本相同。

(2) 方法:采用氦氖激光器波长,6328Å 输出功率10毫瓦,照射光斑直径约2毫米,每穴照射4分钟,1次取4~5穴,隔日1次,10次为1疗程。

5. 方义

四神聪:属经外奇穴,能止头痛平眩晕。太阳:属经外奇穴,如按一般书籍之定位针刺,仅对治疗头痛有效;如按作者经验定位针刺,对高血压中风患者之烦躁不安,不易入睡或失眠多梦,有较好疗效,可与百会配伍使用。哑门、廉泉:分属督任,可疏经气而开机窍,对失语、舌麻、伸舌不居中有效,与头针语言一区同用,有相得益彰之妙。肩髃、曲池、手三里、四渎:分属手三阳经,能疏通经络,治偏瘫上肢疼痛、麻木、沉重、瘫痪有效,如单纯针刺,疗效不佳,必需用电针仪,使手背呈节律性背屈搏动,方能提高疗效。曲泽、大陵、三间、后溪、太白:能疏通经络,治肘、指、趾僵硬强直有效。环跳、委中、髀关、足三里、阳陵泉、犊鼻:分属足三阳经,能疏通经络,治瘫痪下肢疼痛、麻木、沉重、瘫痪有效,也需配用电针仪,使足背呈节律性背屈搏动,方能提高疗效。脾俞:可以健脾利湿。公孙、丰隆分别为足阳明与足太阴之络穴,沟通表里,强化健脾胃、利水湿之作用。肾俞:可以滋阴降火。复

溜为肾经经穴，五行属金，金能生水；太溪为肾之原穴，与复溜皆能资生肾阴。中风患者多嗜膏粱厚味，形体丰腴，或下肢浮肿，皆脾不健运，内湿潴留，针刺脾俞、公孙、丰隆等穴，有益于健运脾胃，调理脏腑，且脾主肌、肾主骨，与中风偏瘫，兼能顾及。考中风一病，病因固由于痰湿风火，但亦常兼见肾阴不足，或久病伤阴，舌光少苔，脉象弦滑，故辨证取肾俞、复溜、太溪等穴，可以滋肾养阴，对肝脾两经亦有裨益。气海：主一身之气，犹如百川汇海，故名气海。中风形体虚胖之患者，舌胖边有齿痕，多属气虚，亦有久病之后，气阴两虚者，针灸此穴能益气收敛。足三里为土经土穴，能益精气，健脾胃，扶正固本。脑户：属督脉，能醒脑开窍，益智宁神。风池、风府、内关，均能活血化瘀，有降血脂及降低血粘度之效。

6. 病案举例

鉴于中风后遗的各种症状，常不是集中出现，在每一病员身上多有所侧重，为便于读者参考，本节拟选病情各有侧重的三个病例，介绍如下。考虑到中风后遗症多数治疗时间较长，故按针灸30次作一治疗小结，观察其针刺效果。

例1 邹×× 女 62岁 门诊号85-1714
1985年5月30日因右半身瘫痪，经瑞金医院

急诊处理,CT检查证实,诊断为缺血性中风。1985年10月12日开始针刺治疗。针前,头痛,眩晕,失语,右上肢肌力1°,痛觉消失,屈肌张力高,右肘僵硬弯曲,右手呈爪样握拳状,不易扳开。下肢肌力4°,痛觉减退,轻度足内翻,步履尚可,可以单独行走。舌体右缘及舌下大片溃疡,进食时由于咸味刺激而感疼痛。脉象弦滑,舌质红,舌下静脉曲张,苔薄黄。血压130/90毫米汞柱。

辨证:血瘀内结,阻滞络道,肝风上扰,久病伤阴。

治则:活血化瘀,疏通经络,平肝熄风,滋阴益肾。

针刺取穴及治疗经过:太阳、风池(均双侧),针刺5次后,头痛眩晕从减轻到消失。廉泉、(头针)言语一区(双侧,电针),针刺6次后开始发音较前清楚,15次后明显清楚,旁人基本能听懂一半。曲泽、大陵、三间、后溪(均患侧)针刺6次后,上肢屈肌张力开始改善,30次后明显改善,别人稍加帮助,右肘、腕、指关节即可基本放松。复溜、太溪(均双侧)针刺14次后,舌质红、舌体溃疡开始好转,以后有反复,22次后明显好转并稳定。曲池、四渎、足三里、阳陵泉(均患侧,电针),针刺30次后,上肢肌力恢复到3°,可以抬到胸部,下肢步履接近正常。

按：本例中風，側重表現在上肢肌力差(1°)、屈肌張力高、失語。中醫辨證屬於陰虛火旺，因此針刺治療有針對性地給予以提高肌力、改善肌張力為目的的疏通經絡、恢復發音和滋陰降火。針刺治療結果：上肢肌力得到部份恢復(3°)，屈肌張力明顯改善，發音好轉，陰虛火旺導致的舌體潰瘍得以愈合。

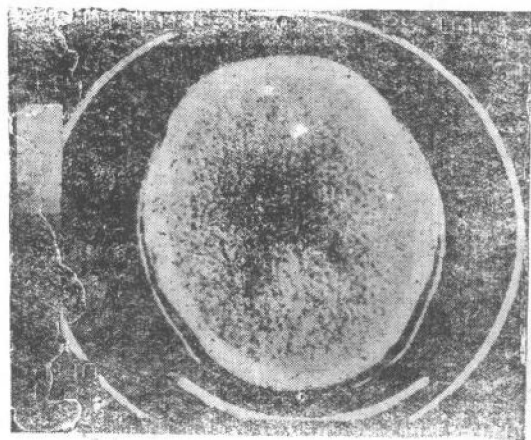


圖10 左半球CT檢查深部淺密度影3×2厘米

例2 俞×× 男 52歲 門診號85-1447
1985年4月11日因左半身癱瘓，在華山醫院急診處理，1985年4月13日腦部CT檢查，提示，左半球深部，相當於內囊部位，見一淺密度影，該影界限不銳利，約3×2厘米大小，符合缺血性中風表現(見圖10)。1985年9月7日開始針刺

治疗。针前，右上肢肌力 2° ，依靠肩胛骨运动，可稍带动上肢，下肢肌力 4° ，略呈内翻足，经人搀扶，可以行走几步，血压130/90毫米汞柱。脉弦，舌质淡，舌下静脉曲张，苔薄黄。甘油三酯588mg%。

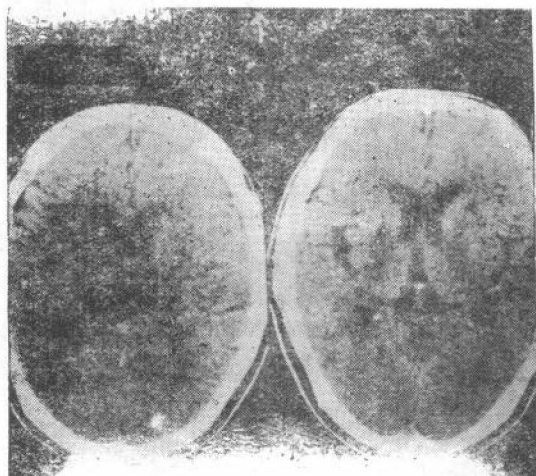


图 11 脑左半球CT复查深部浅密度影缩小
为 1×0.5 厘米

辨证：血瘀内结，阻滞络道。

治则：活血化瘀，疏通经络。

针刺取穴及治疗经过：内关（1侧，左右交替），针刺15次后，甘油三酯从针前588mg%，降低到261mg%，30次后继续下降到160mg%，在针刺期间未同用降血脂药。肩髃、曲池、手三里、四渎（均患侧，分两组交替，电针），（头针）

对侧运动区、感觉区中2/5(电针),足三里、阳陵泉(均患侧,电针),针刺5次后,上肢活动开始好转。15次后能逐步向前平伸并高举过头,向上伸直到170~180°。针10次后,食、中、无名指、小指肌力恢复到4°,可自主伸开到接近伸直,自主内收到接近握拳,30次后拇指能翘起,伸拇指长、短肌腱均可扪及。下肢活动在原有基础上也明显进步,肌力5°,步态接近正常。针刺30次后脑部CT复查,提示:左半球深部之浅密度影明显缩小为1×0.5厘米,界限较前锐利,提示病变较前好转(见图11)。

按:本例中风,侧重表现在上肢肌力差、血脂高,因此针刺治疗有针对性地给予疏通经络以提高肌力,活血化瘀以降低血脂。针刺治疗结果:上肢肌力得到部份恢复(提高2°),甘油三酯从针前588mg%,下降到160mg%。

例3 马×× 男 58岁 门诊号86-2944
1986年4月7日因左半身瘫痪,经瑞金医院急诊处理,诊断为缺血性中风。1986年4月29日开始针刺治疗。针前,左上肢肌力2°,稍抬高肩胛骨稍能带动上肢活动,但活动时肩部疼痛。下肢肌力2~3°,足背、足趾不能背屈,经左右两人挽扶行走。行走时依靠提高左侧骨盆带动下肢,呈痉挛性步态,僵直、拖曳状。左上肢痛觉消

失,下肢痛觉减退。血压180/100毫米汞柱,脉弦滑,舌淡,舌下静脉曲张,薄黄苔。

辨证,血瘀内结,阻滞络道。

治则,活血化瘀,疏通经络。

针刺取穴及治疗经过:天柱、天鼎(均患侧,留针)。肩髃、曲池、足三里、委阳(均患侧,电针)。(头针)对侧运动区、感觉区中2/5(电针)。待体针、头针起针后,天柱、天鼎继续留针10分钟,嘱患者被动抬举上肢锻炼,经针刺5次后,上肢举高时疼痛好转,12次后疼痛消失,肌力明显恢复,15次后肌力恢复到4~5°,能高举到180°。经针刺7次后,下肢屈伸活动开始好转,并能逐渐背屈足背、足趾,20次后下肢肌力恢复到4~5°,屈伸活动基本恢复到正常功能。

按:本例中风,侧重表现在上肢肌力差,活动时肩痛,下肢肌力差,屈伸肌功能均严重下降,足背、足趾不能背屈。这是在中风偏瘫中常见的痉挛步态,因此在治疗时,有针对性地给予提高上肢肌力,并利用天柱、天鼎留针时锻炼功能活动,以改善肩痛,这种针法对肩关节在静止时或活动时(不论主动、被动)疼痛,均有很好疗效。与此同时,还注意提高下肢肌力,对改善僵直、拖曳状的痉挛性步态,均获得明显疗效。

以上所举3例,临床表现各有侧重,是中风恢复期和后遗症期常见的几种类型,特举各例,

以供参考。

7. 体会

(1) 关于病理的认识

从祖国医学观点看，中风恢复期及后遗症期均属血瘀阻滞络道。近年来，通过微循环、血流动力学及血液流变学等几方面的探讨，已发现血瘀的本质是血流缓慢、血液停滞以及血液循环障碍等病理过程[19]。

我们曾观察过 53 例中风偏瘫患者，其中舌紫者 10 例，舌有瘀斑、瘀点者 20 例，以上两项并伴有舌下静脉曲张者 46 例，这种瘀的表现和中医所谓“久病入络为血瘀”是一致的。

根据上述文献报道和我们积累的观察，中风的病因为“瘀阻络道”，其治则为“活血化瘀，疏通经络”应是确切的。

针刺具有活血化瘀的作用，我们曾对舌有瘀斑、瘀点或舌下静脉曲张的 10 例病人，观察手指甲皱微循环的动态改变，发现针刺前有 9 例流速慢，针刺 10 分钟后变快；针刺前 9 例线粒流态，针后 10 分钟有 8 例改变为直线流态；针刺前动静脉形态比例，5 例为 1:3，针刺 10 分钟后改变为 1:2，5 例为 1:4，针刺后 3 例改变为 1:3，2 例改变为 1:2。针刺前 10 例甲皱微循环输入输出枝口径均变细，针后 10 分钟有 6 例恢复。

(2) 关于选穴的体会

治中风选穴宜少而精，以往针治偏瘫，往往囿于《素问·痿论》：“治痿者，独取阳明”之说，以作者实际体验，三阳经及督脉所属不少穴位对中风偏瘫均有效。且应强调重视偏瘫的对症选穴与整体的辨证选穴相结合，不应有所偏废。如头痛、眩晕、反应迟钝、情绪失控等证，我们取百会、四神聪、风池、太阳、脑户等穴，主要考虑到这些穴位均在头部，针刺后有可能直接影响大脑皮层微循环的改善，以达到活血化瘀之目的。用这些穴位在临床上所取得的效果，也证实我们的设想是有一定依据的。关于脑户穴的应用，此穴属督脉，《素问·刺禁论》载：“中脑户，入脑立死，”历代文献均载禁针灸，如宋·王执中《针灸资生经》载：“禁针，针令人哑……亦不可妄灸，令人夭。”等等。但我们在实际临床应用中对醒脑开窍，益智宁神，治动脉硬化所致的精神症状，如反应迟钝、情绪易于波动，哭笑失控等证，有较好疗效。关于古代文献上记载属于禁针禁灸之穴，后世通过大量实践不仅发现可以针灸，且多具有特殊功效，可能在当时由于偶然发生事故，因而禁用，实因噎废食之弊，脑户当为其中之一。

其次，在选穴时，尚须结合现代解剖知识。本书所选上肢肩髃、曲池、手三里、四渎等穴分属上肢阳经，其腧穴所在的肌肉，都是伸肌，

针刺激发其功能,有利于上肢外展运动的恢复。本书所取的下肢环跳、委中、髀关、足三里、阳陵泉等穴,分属下肢阳经,其腧穴所在的肌肉,分别是屈肌或伸肌,针刺激发其功能,有利于下肢屈伸运动的恢复,下肢能屈能伸,其运动功能、步态,自可望得到改善。由于中枢性偏瘫患者下肢伸肌紧张,膝关节弯曲限制,髋关节活动也差,因此,步行时主要靠骨盆携带下肢前向移动,故呈僵直、拖曳状的痉挛步态,要改善这种步态,必需要改善伸肌紧张状态。而针刺这些穴位,并同时用电针仪,加强刺激,对改善伸肌紧张状态,是颇有效益的。

(3) 关于操作的体会

百会:为手足三阳与督脉之会,除可用于中风急性期之开窍升阳固脱外,对中风患者之头痛、眩晕及长期脑血管硬化之精神神经症状,用浅针横刺之操作,并用泻法,能收良效;与脑户、四神聪配伍使用,能提高疗效。

四神聪:根据作者实践体会,四针同时向心浅针横刺,针尖均直达百会穴,不仅能制头痛、眩晕,且对长期脑血管硬化患者之精神神经症状,也有良好疗效,有活血化瘀之作用。四神聪与百会配伍使用时,前、左、右三针仍按向心方向进针,后一针可改向后刺。百会与前、后四神聪成为一直线,能提高疗效。

上述百会、四神聪所取之浅针横刺法，均优于浅针直刺，可能由于针刺面广，会相应产生较大刺激量，从而提高疗效。

风池：作者在实践中体会到本穴进针方向颇为重要，能直接影响疗效。用于治疗高血压、目糊伴头额胀痛之中风患者，应取同侧瞳孔直视方向进针。其定进针方向之操作法，可嘱患者取后靠坐位，医者立于患者左侧，右手持针破皮进针后，先勿急于深入，另以左手食指伸直置于同侧瞳孔直视方向，定好点；右手所持之针与左手食指成一直线，医者可在患者顶部居高临下俯视，是否成一直线，待针体与左手食指确成一直线后，不要移动针体，然后缓缓进针，达1寸左右深度后，小幅度捻转导气，不宜幅度过大，免致局部针感过强。经小幅度捻转导气上行，针感可达同侧颞部、额部或阳白穴和眼区（请参阅图1、2）。

（4）关于针灸治疗效果的差异

① 关于后遗症期效果的差异：中风偏瘫病人，其瘫痪肢体在后遗症期，多出现肌张力明显增高，肘、腕、指关节僵硬，屈曲握拳姿势等硬瘫症状。然而据我们长期观察有些病人的远端肢体，可一直处于弛缓状态，指、掌部份早期呈浮肿，当浮肿消退后，即出现废用性肌痿。我们在临床中发现，手指僵硬，取大陵等穴针刺后，

可即刻改变屈曲握拳姿势,手指伸开,虽然几分钟或几小时后仍基本回复原状,但针刺具有累积作用,经多次针刺后,可使症状明显改善。而部份弛缓状态的患肢,针刺虽有一定效果,但较之前者为差。

另外,根据我们观察,在恢复期已经取得较好进步的,在后遗症期多数能逐步恢复,如从发病开始,6个月内尚无明显改善,多数预后较差。

② 发病年龄的差异:我们统计53例针刺治疗中风的患者,其年龄分别从50岁到70岁,从年龄来分析,未发现年龄与疗效之间有一定联系。

③ 有无其它合并症的差异:同时有无其它全身系统性疾病和严重并发症的问题,对中风预后十分重要。我们分析针刺治疗无效者除病灶本身有重要因素外,同时还伴有全身系统性疾病,如糖尿病、肾功能衰竭、机体抵抗力低下和肺炎等严重并发症。

④ 针刺治疗和药物治疗效果的差异:我们曾分析针刺治疗53例中风患者,其中显效者13例,有效者31例,无效者9例,总有效率为83.0%。显效的标准是肌力增加2度以上,有效标准是肌力增加在1~2度之间,无效标准肌力增加低于1度。另取41例对照,两组均为住院病人,年龄、病情大致相仿,对照组仅接受一般药

物治疗,与针刺组类同,疗效判别标准相同,以资比较。结果对照组显效者12例,有效者14例,无效者14例,总有效率为63.4%。两组治疗效果对比观察表明,针刺对偏瘫的治疗有效率要比对照组明显提高($P < 0.05$)。

(5) 谈谈偏瘫恢复的几个有关问题

① 中风性质对偏瘫恢复的影响,一般认为出血性中风偏瘫的恢复差于缺血性,但经我们统计53例中风偏瘫,包括38例缺血性中风,15例出血性中风。诊断标准符合1978年第二届全国神经精神科学学术会议的规定^[20]。在38例缺血性中风中,经针刺治疗1个月左右,显效9例,有效22例,无效7例,总有效率为81.6%,其中显效率为23.7%,15例出血性中风,同样经针刺治疗1个月左右,显效4例,有效9例,无效2例,有效率为86.6%,显效率为26.7%。疗效标准详前。根据这两组病例分析,两类中风偏瘫的针刺疗效接近。

② 针灸疗效的预测:根据我们对53例均由脑部CT明确诊断的中风患者的分析,其中无效的9例,病灶都很大,位于深部或两侧,或多灶,或累及脑干(脑干卒中),临床瘫痪严重,且常伴有失语。因此可以说为什么某些偏瘫患者在开始中风时其症状差异不大,但其疾病的发展和预后却迥然各异。这些临床观察的结

果，证实病灶的大小和瘫痪的严重程度基本上是一致的，而多灶患者多数瘫痪严重，针刺治疗效果也较差，且预后不良。所以早期用脑部CT所提示的内容，可以作为针灸治疗中风疗效的一项预测手段。

③ 针灸治疗偏瘫的时机：以往曾有人认为中风病人必需在病情稳定后再过一段时间方能针刺治疗，在我们统计的53例中风偏瘫患者中，发现1~3周内开始针刺的病人总有效率为80.3~96.4%，3周以后开始针刺的病人总有效率为53.8%，经统计学处理， $P < 0.05$ 。所以我们认为应该争取早期治疗。

④ 针灸治疗偏瘫的法则：中风恢复期和后遗症期的治疗，一般多着眼于偏瘫的恢复。我们认为整体辨证论治并不亚于肢体偏瘫的重要性，正如前文所述血瘀既为致瘫的重要因素，因此给予活血化瘀，不仅成为当务之急，还需持之以恒，即使患者不再诉说头痛、眩晕等证，经常针刺头部诸穴，以改善或加速其大脑皮层微循环的流通，仍然是必要的。关于整体治疗，除上述活血化瘀外，还应考虑到有针对性地平肝熄风，利湿化痰，对于久病伤阴者，还需考虑益肾养阴，保存正气，这些治疗都有助于整体康复，一旦整体康复明显，也会对局部证候产生有益影响。所以我们认为选穴配方应着眼于整体

治疗与局部治疗的有机结合。

⑤ 针灸治疗偏瘫方法的差异：对激发肢体功能恢复有关，我们认为单一的留针，不及在有针对性的穴位上加用电针法。例如上肢瘫痪手背手指不能背屈，足内翻呈痉挛步态等，取同样穴位，加电针后，使手、足背呈节律性背屈，对功能恢复，比之单一针刺，疗效能明显提高。除上述电针外，针刺某些穴位在留针时瘫痪肢的活动与否，效果也不一样。例如对抬举上肢困难并伴有肩关节疼痛者（不论主动运动或被动运动），我们发现在患侧天柱、天鼎两穴，可扪及有结节、压痛，按经络观点来解释是络道阻滞，所以循经会出现结节、压痛，在该两穴进针后，在留针时间内，要求患者抬举上肢（主动或被动），对消除疼痛、改善功能活动有明显效果。这些结节、压痛均会随症状的缓解及功能的恢复而减轻和消失。至于其机理尚有待探讨。

在针刺方法上，自从发现头皮针后，对中风偏瘫的针刺治疗增加了一个重要的有效手段，但我们通过大量实践，发现仅用头皮针，不能完全满足治疗上的需要，而且长期使用头皮针会出现病情恢复缓慢，似乎产生了适应性，因此把头皮针和体针（通电麻仪）按疗程交替使用，或以体针为主酌加头针，或以头针为主酌加体针，也可按疗程交替使用，发现这种方法可以提高

疗效。

⑥ 坚持锻炼对偏瘫恢复的影响：患者自身坚持锻炼十分重要。在功能尚未恢复前，他人必需给予足够的被动运动，包括上下肢每个可以活动的关节，患者必需密切配合。例如抬举上肢时，肩部会出现疼痛，患者必需尽可能忍耐，密切配合。我们发现不少患者由于对坚持锻炼的态度不同，首先表现在肌肉萎缩程度上的差异，这与功能恢复直接有关。需要指出的是，上肢瘫痪的患者，往往在不太长的时间内即会出现肩部韧带松弛，形成近似假性脱臼，会增加抬举上肢困难，影响功能恢复；在病程稍长之后，由于患者长期不能抬举上肢，逐渐出现关节粘连，因而在被动抬举时会出现肩关节痛，又会因疼痛而不愿被动运动，进一步增加粘连而加剧运动时疼痛，如此恶性循环，必然使上肢功能恢复增加困难。因此根据我们的经验，当患者开始离床活动时起，就必须嘱咐患者屈曲患侧上肢成 90° ，用三角巾托住前臂，固定于胸前，除卧位、被动运动外，不要解开三角巾，放下前臂，如此可以避免韧带松弛。这一措施，我们使用已久，对上肢恢复，颇有裨益。

(6) 关于疗效的评定标准

通常临床报道所定的疗效标准，多分“临床治愈”、“显效”、“有效”等项，虽各有其内容，但

常嫌界限不够清楚,容易互相混淆,为了谋求一种计算疗效的定量计算标准,我们曾拟“运动功能”和“生活自理能力”各立两项标准,均以打分计算,根据得分多少,评定治疗效果。这种打分法,是一种定量算法,能较为准确地评定治疗效果。其内容如下:

① 运动功能:设计10个动作,根据动作完成程度打分:0分无法做动作,1分能完成50%,2分完成动作可达75%,3分动作完成超过75%,4分完成100%。其中拇对指这一项内“0”分为不能,以下按拇指能触及的指数各给1分。10个动作完全完成为满分,应是40分。

上述10个动作内容是:肩外展90°、前臂转

吃饭	自理	10分	需要帮助	5分	别人喂饭	0分
洗脸	自理	5分			不能自理	0分
梳头	自理	5分			不能自理	0分
穿衣	自理	10分	需要帮助	5分	依靠别人	0分
站立	自己站立	5分			不能站立	0分
坐下	不要别人帮助	5分			不能自己坐下	0分
蹲下	不要别人帮助	20分	需要帮助	5~15分	不能蹲下	0分
上床睡下	自理	15分	需要帮助	10分	能靠坐床上,需要帮助移动	5分
行走	独立	15分	经帮助可行走	5~10米, 5~15分	不能行走	0分
上楼	独自	10分	需要帮助	5分	不能	0分

动90°、臂转动90°、伸掌、握拳、拇对指、下肢外展内收、屈膝、伸膝、足背伸屈。

② 生活自理能力：拟定10个生活项目，根据自理能力及难易程度，每个项目满分从5~20分不等，恢复正常后，共可得100分（见54页表）。

总的来说，针刺治疗偏瘫，在恢复期和后遗症期是有效的方法之一，但目前仍存在一些 问题，例如治疗失语，除早期有效外，在后遗症期即无效或疗效很差；肢体僵硬明显者针刺有一定效果，而对弛缓状态的患肢，针刺效果尚不理想，等等，这些问题，仍有待于进一步探索有效措施，提高疗效。

（二） 古代经验

1. 成方选辑

《针灸甲乙经》

偏枯，四肢不用，善惊，大巨主之；不仁筋急，大陵主之；五指掣不可屈伸，腕骨主之；不能行，照海主之。

《千金翼方》

治狠退风，偏风半身不遂法：肩髃，针入八分，留三呼，泻五吸；曲池，入七分，得气即泻，然后补之，灸日十壮至一百壮止，十日更报，不少至二百壮；列缺，入三分，留三呼，泻五吸，亦可灸之，日七壮至一百壮，总至三百壮；阳池，针入三分，留三呼，泻五吸，忌灸；商丘，针入四分，留

三呼，得气即泻，疾出针，于痕上灸之良，七壮。

《针灸资生经》

半身不遂，若灸，当先百会、囟会，次风池、肩髃、曲池、合谷、环跳、风市、（足）三里、绝骨。

《扁鹊神应玉龙经》

中风半身不遂：合谷、手三里、肩井、曲池、环跳、血海、阴陵泉、阳陵泉、足三里、绝骨、昆仑，先于无病手足针，宜补；次针有病手足，宜泻。

《普济方·针灸门》

偏风，宜针下项七处，灸亦得。穴风池、肩髃、曲池、支沟、五枢、阳陵泉、巨虚下廉。

中风失音，天突，针入三分；支沟，针入三分；涌泉，针入五分。舌急不语，刺哑门，针入二分，舌缓不语，刺风府。

《针灸聚英·杂病十一穴歌》

风池手足指诸间，右痪偏风左曰瘫，各刺五分随后泻，更灸七壮便身安，三里、阴交行气泻，一寸三分量病看，每穴又加三七壮，自然瘫痪即时安。

《针灸大成》

阳症中风，不语，手足瘫痪者：合谷、肩髃、手三里、百会、肩井、风市、环跳、足三里、委中、阳陵泉，先针无病手足，后针有病手足。

阴症中风，半身不遂，拘急，手足拘挛，亦依治之，但先补后泻。

《类经图翼》

偏风半身不遂，左患灸右，右患灸左，肩髃、百会、肩井、客主人（主口歪）、列缺、手三里、风市、曲池、阳陵泉、环跳、足三里、绝骨、昆仑、申脉。

偏风口喎：听会、合谷。

音哑：天突、灵道、阴谷、丰隆、复溜、然谷。

2. 评述

历代有关针灸治疗中风的载述，其最主要部份是恢复期或后遗症期的治疗。重点又在半身不遂证候上。最早见于《内经》，但甚为简略。《针灸甲乙经》开始注意到根据其不同症状表现来选穴，但多仅一症取一穴，如偏枯不用取大巨，偏枯不仁取大陵等。自唐代起，取穴逐渐增多，操作上不断改进。

用穴规律：综观各种有关典籍记载，治疗半身不遂，主要采用：风池、肩髃、曲池、合谷、手三里、中渚、环跳、阳陵泉、绝骨、足三里、委中、昆仑、行间等。

治疗口喎：颊车、地仓、列缺、客主人、听会、合谷。

治疗失语：天突、哑门、灵道、神门、涌泉。

治法特点：①强调针灸并用，早期的《千金翼方》就主张针后加灸，以提高疗效。就时期看，唐、宋偏重灸疗，元、明多倡针刺，而总的仍

以针治为主。②刺法提倡“巨刺法”，主张右病左取、左病右取。古代医家十分主张取健侧经穴。有两种方法，一是左病右取、右病左取，单取一侧穴；一是先取健侧穴，再针患侧穴，有的还分别采用不同手法，如《扁鹊神应玉龙经》即提出“先于无病手足针，宜补，次针其有病手足，宜泻。”值得一提的是，古人提出左病右取是有一定依据的，如《类经图翼》针对中风所出现的口喎，提出“凡口喎向右者，是左脉中风而缓也，宜灸左喎陷中二七壮；喎向左者，是右脉中风而缓也，宜灸右喎陷中二七壮。”但是也有不同看法，如宋·王执中《针灸资生经》即提出治半身不遂“不必拘旧经病左灸右、病右灸左之说，但按酸痛之处灸之，若两边灸亦佳，但当自上而下灸之。”③重视针刺手法：手法的应用，首先在于辨证，明代杨继洲把中风的半身不遂，分为阳症和阴症，从各自表现的症候上看，阳症半身不遂泛指早期瘫痪而言，阴症相当于肌张力增高的后期症状。在治疗阴症时，主张“亦依（阳症）治之，但先补后泻”（《针灸大成》），手法有所不同。其次，要求通经接气，元代针灸家在《标幽赋》中提出：“痹厥偏枯，迎随俾经络接续”，《金针赋》介绍更为详细，“至夫久患偏枯，通经接气之法，有定息寸数……在乎摇动出纳，呼吸同法，驱运气血，顷刻周流，上下通接……若开渠

之决水，立时见功，何倾危之不起哉。”应用导气疗法，促使针感传导，能提高疗效，已获得公认，我们临床实践体会，对中风恢复期及后遗症的治疗，亦不例外，确有较好的疗效。④探究提高疗效的方法：中风瘫痪是难治病症之一，古人比较重视研究分析针灸疗效不佳的原因，以求获得较好的效果，这一点在《针灸大成》中有明确的记载，认为针效不显，首先与病情有关，如“风痰灌注经络，气血相搏，再受风寒湿气入内，凝滞不散，故刺不效”；其次，与针刺手法有关，“针力不到，补泻不明，气血错乱，或去针速，故不效也。”另外，有的患者，针后病症复发，亦认为与“针不知分寸，补泻不明，不分虚实”有关，治疗方法是“其症再发，再针前穴”。以上这些内容，对今天的临床仍有一定借鉴意义。

（三）现代报道

1. 体针之一

（1）取穴

主穴：内关、水沟。

辅穴：极泉、委中、三阴交、尺泽。吞咽困难加风池、翳风。手指屈曲不能加合谷。失语加金津、玉液。

（2）操作

先取主穴，据症加用辅穴。先刺双侧内关，直刺1~1.5寸，采用提插捻转手法（泻法）1分

钟。继刺人中，向鼻中隔下斜刺5分，用雀啄法（泻法），至流泪或眼球湿润为度。刺三阴交，针尖向后斜刺与皮肤成45度角，进针1~1.5寸，采用提插手法（补法），到病人下肢抽动3次为度。极泉，宜直刺进针1~1.5寸，提插法（泻法），至上肢连续抽动3次为度。尺泽针法同极泉。取委中须仰卧抬腿取穴，进针1~1.5寸，采用提插法（泻法），至下肢抽动3次为度。针风池，针尖应向喉结，进针0.8~1.0寸，采用快速捻转手法，运针半分钟。针翳风同风池。合谷，针尖宜指向三间处，第二掌骨下缘部位，用提插法（泻法）。金津、玉液以三棱针点刺。每日根据症状，针刺1~2次，10天为1疗程，间隔3~5天，继续治疗。

（3）疗效评价

本法适用于脑溢血恢复期及脑梗塞任何一期治疗。

疗效标准：①临床治愈：思维正常，语言清楚，肢体功能基本恢复；②显效：思维、语言、上肢及下肢的障碍有一项恢复不完全者；③有效：病情有进步，上述功能障碍有一定恢复。

共治671例，其中54例为脑溢血恢复期，临床治愈28例（51.8%），显效15例（27.8%），有效11例（20.4%），总有效率为100%。617例为脑梗塞患者，临床治愈366例（59.3%），总有效率

为99.4%[4,21]。

2. 体针之二

(1) 取穴

① 肢瘫。主穴：肩髃、曲池、外关、合谷、环跳、阳陵泉、足三里、太冲、悬钟。配穴：肩贞、后溪、风市、秩边、昆仑、解溪、丰隆。

② 面瘫。主穴：颊车、地仓。配穴：迎香、颧髎。

③ 失语。主穴：哑门、廉泉。配穴：天突、少商、耳府。

(2) 操作

以主穴为主，酌配辅穴，每次选5~8穴，一般仅取患侧，效果不显，可加刺健侧。平补平泻，持续捻转提插2分钟后，留针15~20分钟，每5分钟运针1次，刺激强度以病人能耐受为度。亦可选其中1~2对穴，接通电针仪，频率120次/分，锯齿波，通电15分钟。每日1次，10次1疗程。如上法治疗效果不明显时，亦可采用三步刺法，第一步单取健侧经穴，用泻法，行针2分钟，急令病人强行活动患肢，如无动静，隔10分钟后，重复操作1次，如仍无效，于24小时后，重复施术，待患肢稍能活动，即行第二步，以健侧经穴为主，用泻法，患侧为辅，用补法；待明显改善后，进入第三步，即为患侧为主，施行补法。

(3) 疗效评价

此法适用于后遗症期,共治 985 例,总有效率在 83.0%~96.9%[8,22~26]。

3. 头针

(1) 取穴

主穴:运动区、足运感区。

辅穴:语言 2 区、感觉区。

(2) 操作

每次以主穴为主,言语不利加语言 2 区,感觉障碍加感觉区。一般取对侧穴区,足运感区针双侧。用 28 号 1.5~2 寸毫针,沿头皮刺入至一定深度,以每分钟 200~240 次频率持续捻转 3~5 分钟,使患侧肢体出现麻热感、抽胀感或出汗为佳,留针 15 分钟,再捻转 2~3 分钟,继续留针 15~20 分钟。

(3) 疗效评价

据观察,此法对中风恢复期疗效较好。治疗中风恢复期及后遗症期患者 577 例,总有效率在 93.42~95.0% 之间[27~29]

4. 眼针

(1) 取穴:

上焦、下焦(以患侧为主,可配合健侧)。

(2) 操作:

用点眼棒或三棱针柄在眼周眶区的范围内,均匀用力,轻轻按压,出现酸、麻、胀、重或发热、发凉,或微痛,或有舒适感均为穴位反应。

以左手手指按压眼球,使眼眶皮肤绷紧,右手持32号5分毫针,在眼眶边缘2分许处,轻轻刺入,以瞳孔为中心察准经区界限,在经区界限内沿皮直刺或横刺,不用手法,顺着眼针经穴分布顺序进行为补,反之为泻,留针5~15分钟。

(3) 疗效评价:

本法只限于神态清醒,无邪在脏腑的症状,肌肉、肢体均未变形,仅是肌力由 $0\sim3^\circ$ 的半身不遂患者,病程愈短,效果愈好。曾对453例患者治疗观察,发现病程在3个月以内者,针1次即能离床行走的达84例,三个月以上病程的病人,针1次能行走的为18例。应用本法治疗,总有效率在97%左右(痊愈率23.1%)[30~31]。

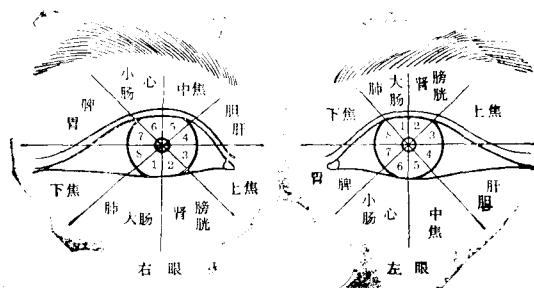


图 12 眼针穴位分布示意图

附:眼区经区划分法 共分8个经区13个穴,每区占的范围相等,均各占眼睑周围 $1/8$ (见图12)。穴在眼眶外一周,距离眼球约一横指,上眶在眉毛下际,下眶离眼眶边缘2分许。

二、 其它措施

(一) 根据病情,可配合应用低分子右旋糖酐静脉滴注,以改善微循环,及应用脱水剂减少脑水肿等,另外,可用活血化瘀的中药。

(二) 加强功能锻炼,包括语言训练及肢体活动等。

结 语

针灸防治中风,如上所述,古代已积累了丰富的经验,现代亦取得了较大进展,大量的长期的临床观察及机理研究都已证明针灸确是一种安全简便、行之有效的疗法。但是,如果作为成熟的疗法来评价,据我们看尚存在以下几个问题。

一、中风急性期,主要是脑溢血昏迷期,针灸可作为中西医结合救治的主要辅助疗法之一。这方面的工作,五、六十年代做得较多,近年来质量较高的临床报道鲜见。而在具体治法上,主要还是沿袭古人的方法,改进及发展不大。我们认为,随着现代诊断和救治技术的迅速提高,如何使针灸治疗成为中风急救的有机组成部分,并采用某些可靠的客观指标(如CT等)确切地评价针灸的实际价值,是一个十分值得探讨的问题。

二、针灸治疗中风效果的预测问题，对选择疗法，判断预后都有重要的意义。这一工作尚未引起足够的重视，如前所述，我们曾应用CT技术检测，据颅内病灶的范围、部位来判断预后，虽有一定价值，但这仅是初步的，有待应用更多更有说服力的现代检测手段，加以深入研究。

三、针灸预防中风，古籍中保存了大量有价值的内容，从目前个别单位的验证结果看，效果确切，因此有必要进一步挖掘继承，总结提高。防未病，是祖国医学中的最重要观点之一，应该把预防提高到和治疗同等程度。

四、现代在中风救治上作了大量工作，今后，我们认为还须更深入地揭示和总结其临床规律，包括有效穴位的筛选和研究，针刺手法的规范化，用现代技术设备探讨其确切的治疗机理，等等。我们在本书中正是试图从这一角度对古代和现代及个人的经验作一小结，还很粗浅，目的在抛砖引玉。

我们深信，只要针灸工作者和现代科学特别是现代医学工作者竭诚合作，那么，针灸这颗古老的明珠，将会放射出更加夺目的光彩，而针灸防治中风的水平，将会随之出现新的飞跃。

参 考 文 献

- [1] 王文锦: 针灸配合中药治疗急性脑出血昏迷34例临床初步观察, 中医杂志, 1959; (10): 51。
- [2] 黄美明等: 40例中风辨证论治体会, 上海中医药杂志, 1964; (1): 13。
- [3] 中医研究院, 针灸研究进展, 第一版, 北京, 人民卫生出版社, 1981: 318。
- [4] 天津中医学院第一附属医院脑血管病组: 醒脑开窍针刺治疗脑梗塞617例的临床观察, 云南中医杂志, 1982; (2): 28。
- [5] 邓 正: 中西医结合“针体疗法”治疗脑血管意外后遗症35例临床观察, 阜阳医药, 1975; (1,2): 49。
- [6] 蒋树达等: 针刺治疗急性中风病人的疗效和血液流变学变化观察, 中国针灸, 1983; 3(6): 1。
- [7] 章惟贤、方幼安等: 中风偏瘫的针刺治疗与 C T 检查, 上海针灸杂志, 1986; 5(1): 11。
- [8] 邱茂良等: 针刺对中风患者脑血流图与血液流变学等治疗后的变化观察, 中国针灸, 1984; 4(2): 1。
- [9] 中医研究院针灸研究所神经科: 针刺治疗脑血栓形成及其恢复期 209 例和对脑血流图、肌电图的影响观察, 全国针灸针麻学术讨论会论文摘要(一), 80, 1979。
- [10] 蒋树达等: 针刺对缺血性脑血管病病人机电幅度的影响, 中国针灸, 1982, 2(4): 40。
- [11] 上海第一医学院华山医院: 实用神经病学, 第一版, 上海科学技术出版社, 1978: 475。
- [12] 赵和熙、张仁等: 针刺内关穴对高血脂的影响, 中西医结合杂志, 1984; 4(11): 666。
- [13] 彭悦等: 氦氖激光照射内关穴治疗高血脂症50例的临床

- 床观察, 中国针灸, 1986; 6(2): 15。
- [14] 上海市卫生局: 中医研究工作资料汇编(第二辑)第1版, 上海, 上海科学技术出版社, 1958: 102。
 - [15] 陈大中等: 疤痕灸防治高血压病的临床探讨, 同[9]: 41。
 - [16] 方幼安等: 耳针戒烟的临床研究, 第二届全国针灸针麻学术讨论会论文摘要, 17, 1984, 北京。
 - [17] 方幼安等: 耳针戒烟与味觉、血浆脑啡肽关系的研究 上海针灸杂志, (3), 1, 1985。
 - [18] 陈道志等: 针刺曲池、丰隆对原发性高血压的疗效及血液动力学的影响, 第二届全国针灸针麻学术讨论会论文摘要, 9, 1984, 北京。
 - [19] 秦万章等: 血瘀证的本质及活血化瘀原理的初步探讨, 自然杂志, (2), 2, 115~118。
 - [20] 第二届全国神经精神科学术会议: 急性脑血管病分类(试行草案), 中华神经精神科杂志, 11; 27, 1978。
 - [21] 石学敏等: 针刺治疗脑出血 54 例临床分析, 中国针灸, 4(5): 11, 1984。
 - [22] 马瑞林等: 针刺中风及后遗症 258 例临床观察, 中国针灸, 1984; 4(2): 9。
 - [23] 山东省立中医院针灸科: 针灸治疗中风瘫痪 134 例临床初步观察, 山东医刊, 1960; 3: 19。
 - [24] 苏尔亮: 巨刺三步法治疗 102 例中风后遗症的疗效观察, 中医杂志, 1980; 21(8): 30。
 - [25] 武汉第一医院针灸科: 针刺治疗脑血管意外 283 例, 江苏中医杂志, 1980, (4): 47。
 - [26] 陆树德: 针刺治疗中风偏瘫 162 例, 江苏中医杂志, 1981; 2(4): 41。
 - [27] 李惠芳等: 头针及针灸治疗脑血管病偏瘫 318 例疗效分析(附一例报告), 北京医药, 1980; (4): 256。

- [28] 王燕思: 头皮针治疗脑血栓形成59例, 中国针灸, 1982; 2(3): 48。
- [29] 大连铁路医院内科: 头针治疗急性脑血管疾病200例, 辽宁医药, 1977; (2): 28。
- [30] 彭静山等: 眼针治疗中风 242 例临床观察, 辽宁中医杂志, 1983; (11): 30。
- [31] 彭静山等: 眼针对偏瘫预后的探讨, 辽宁中医杂志, 1984; (9): 42。